

PRÉPARATION DU CONCOURS DE RÉSIDANAT

SUJET 63.

SCHIZOPHRÉNIE

QUESTIONS À CHOIX MULTIPLES OU À CHOIX UNIQUE

1/ La schizophrénie est caractérisée par :

- A. Une évolution chronique
- B. Un syndrome d'excitation
- C. Un délire bizarre
- D. Un mode de début toujours progressif
- E. Une évolution continue des symptômes

2/ La schizophrénie est caractérisée par :

- A. Une durée de six mois ou plus des symptômes
- B. Une évolution qui peut être faite de périodes de rechutes et de périodes de rémission
- C. L'absence de retentissement social ou familial
- D. L'existence d'un risque suicidaire
- E. L'évolution vers la résistance dans la majorité des cas

3/ Au cours de la phase pré-morbide de la schizophrénie, on peut observer :

- A. Des troubles des fonctions exécutives
- B. Des idées délirantes
- C. Des troubles de l'attention
- D. Un retrait social
- E. Des signes neurologiques mineurs

4/ Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui évoqueront un début de schizophrénie :

- A. Des conduites sexuelles en rupture avec le fonctionnement antérieur
- B. Des idées obsédantes avec une lutte anxieuse manifeste
- C. Une symptomatologie dépressive avec un contact détaché
- D. Une phobie ou une anxiété soulagée par la réassurance
- E. Des situations phobogènes multiples sans lien entre elles

5/ Les modes de début aigus de la schizophrénie sont :

- A. Un passage à l'acte de caractère immotivé
- B. Une phobie avec une lutte anxieuse
- C. Un épisode psychotique aigu
- D. Des épisodes d'allure maniaque ou des épisodes dépressifs
- E. Des obsessions sans lutte anxieuse

6/ Devant un épisode psychotique aigu, quels sont les éléments qui évoqueront une entrée dans la schizophrénie ?

- A. Une bonne adaptation pré-morbide
- B. L'existence d'un émoussement affectif
- C. Un début progressif de la symptomatologie
- D. L'absence de confusion mentale à l'acmé de l'épisode psychotique
- E. L'installation des troubles observables par l'entourage en moins de un mois

7/ Devant un syndrome maniaque, vous évoquez une schizophrénie débutante devant :

- A. L'euphorie
- B. L'absence de ludisme
- C. L'existence de gestes bizarres
- D. Un déroulement des idées avec des associations par assonance
- E. Des idées qui se bousculent selon une trame incohérente

8/ Lesquels parmi ces propositions constituent un mode de début progressif de la schizophrénie :

- A. Une manie atypique
- B. Un fléchissement de l'activité avec une modification du caractère
- C. Une symptomatologie pseudo-névrotique
- D. Un épisode psychotique bref
- E. Un trouble de l'adaptation

9/ Le(s)quel(s) parmi ces signes fait (font) évoquer un début de schizophrénie devant des idées obsédantes ?

- A. Une lutte anxieuse
- B. Des mesures d'évitement absentes ou inorganisées
- C. Déviations des conduites sexuelles
- D. La bizarrerie des rituels
- E. La réassurance inefficace ou non recherchée

10/ Devant un jeune présentant un fléchissement de son fonctionnement, vous évoquerez une schizophrénie si :

- A. Le patient continue à assumer les tâches qu'il doit exécuter
- B. L'entourage ne remarque pas les changements du comportement
- C. Des croyances à des phénomènes surnaturels se développent
- D. La pensée devient de plus en plus allusive
- E. Le contact du patient est adapté

11/ Dans les phases initiales de la schizophrénie :

- A. Les idées délirantes de transformation corporelle sont fréquentes
- B. Les idées délirantes d'installation insidieuse peuvent se voir
- C. Le fonctionnement reste toujours adapté jusqu'à la phase d'état de la maladie
- D. L'installation des symptômes est toujours aiguë
- E. Le patient néglige de plus en plus les tâches qu'il doit exécuter

12/ Le syndrome délirant au cours de la schizophrénie se caractérise par :

- A. Un seul thème délirant
- B. Un mécanisme hallucinatoire plus prévalent
- C. Des hallucinations qui peuvent concerner toutes les modalités sensorielles
- D. Une bonne systématisation
- E. Une extension en réseau

13/ Quels sont, parmi les propositions suivantes, ceux qui évoqueront la présence d'hallucinations auditives :

- A. Une soliloquie
- B. Une distractibilité pendant l'entretien
- C. Se boucher les oreilles
- D. Un signe du miroir
- E. Une attitude d'observation

14/ Qu'est ce qui caractérise un mécanisme interprétatif d'un délire ?

- A. Élaboration d'idées délirantes à l'instar d'un romancier
- B. Élaboration d'explications fausses à un fait réel
- C. Adhésion à des idées délirantes qui surgissent dans la conscience du sujet
- D. Avoir l'impression de pensées devancées
- E. Reasonner à partir d'arguments ne reposant sur aucun élément de réalité

15/ L'incapacité à entreprendre et à planifier des actions correspond à :

- A. Un apragmatisme
- B. Une clinophilie
- C. Un maniérisme gestuel
- D. Une catalepsie
- E. Un négativisme

16/ Le(s)quel(s) parmi ces signes caractérise(nt) le syndrome de désorganisation ?

- A. Des troubles des associations idéiques
- B. Des « coq-à-l'âne » ou des associations absurdes
- C. L'impression que la pensée est devinée
- D. Des raisonnements d'allure scientifique ou philosophique détachés du réel
- E. La dépersonnalisation

17/ Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui font partie de la désorganisation de la pensée ?

- A. Des suspensions du cours des idées
- B. La perte de l'élan vital
- C. L'existence d'une flexibilité cireuse
- D. La froideur dans le contact
- E. Une diffluence faite de digressions incontrôlables et sans rapport entre elles

18/ Les(s)quel(s) parmi ces signes caractérise(nt) la désorganisation affective ?

- A. Des suspensions du cours des idées
- B. Des contaminations d'une idée par une autre
- C. Des idées de persécution et d'ensorcellement
- D. Une ambivalence affective
- E. Un contact de bonne qualité

19/ Ces signes cliniques font partie du syndrome catatonique :

- A. Le refus de la main tendue
- B. La conservation des attitudes imposées
- C. L'ambivalence affective
- D. L'athymhormie
- E. La flexibilité cireuse

20/ Une flexibilité cireuse des membres avec maintien des attitudes imposées correspond à :

- A. Un négativisme
- B. Un maniérisme gestuel
- C. Une parakinésie
- D. Une catalepsie
- E. Une aboulie

21/ Une imitation non volontaire en miroir des gestes de l'interlocuteur correspond à :

- A. Une échopraxie
- B. Une écholalie
- C. Une paramimie
- D. Une mauvaise coordination des mouvements
- E. Une catalepsie

22/ Les domaines cognitifs les plus altérés chez une personne présentant une schizophrénie sont :

- A. Les fonctions de planification
- B. La mémoire procédurale
- C. L'attention
- D. La vitesse de traitement de l'information
- E. La flexibilité mentale

23/ Les altérations des fonctions cognitives chez une personne présentant une schizophrénie :

- A. Sont rares
- B. Sont sévères
- C. Précèdent le début de la maladie
- D. S'aggravent lors de l'émergence des symptômes psychotiques
- E. Concernent les fonctions exécutives

24/ Les facteurs de bon pronostic chez une personne présentant une schizophrénie sont :

- A. Un début précoce de la maladie
- B. Un genre féminin
- C. Une bonne conscience du trouble
- D. Un bon fonctionnement pré-morbide
- E. Un support social défavorable

25/ La surmortalité documentée chez les personnes présentant une schizophrénie peut être liée :

- A. Au passage à l'acte suicidaire
- B. A la sédentarité
- C. Aux effets indésirables des antipsychotiques
- D. Aux anomalies cardio-métaboliques associées
- E. Au sevrage des substances psychoactives

26/ La prise en charge de la schizophrénie associe :

- A. La réintégration sociale du patient
- B. La prescription d'un thymorégulateur
- C. La prescription d'un antipsychotique
- D. Une psychothérapie
- E. La prescription d'un anxiolytique

27/ Les antipsychotiques classiques peuvent avoir comme effets indésirables :

- A. Une photosensibilité au soleil
- B. Une prise de poids
- C. Des dyskinésies aiguës
- D. Une élévation du seuil épileptogène
- E. Un syndrome malin

28/ Les antipsychotiques atypiques ou de seconde génération sont :

- A. Indiqués de première intention pour le traitement de la schizophrénie
- B. Dénués d'effets indésirables métaboliques
- C. Mieux tolérés sur le plan neurologique que les antipsychotiques classiques
- D. Plus efficaces que les antipsychotiques classiques sur les signes négatifs de la schizophrénie
- E. Prescrits sans bilan biologique préalable

29/ La surveillance au long cours d'un traitement antipsychotique comprend :

- A. Une glycémie une fois par an
- B. Une uricémie une fois par an
- C. Un bilan thyroïdien tous les trois mois
- D. Un bilan hépatique une fois par an
- E. Une protéinurie de 24 heures une fois tous les six mois

30/ Le choix de l'antipsychotique à proposer à un patient présentant une schizophrénie est déterminé en tenant compte des principes suivants :

- A. Prendre en considération le tableau clinique présenté par le patient
- B. Prendre en considération la réponse antérieure du patient aux antipsychotiques qui lui ont été prescrits
- C. Privilégier la molécule la mieux tolérée
- D. Associer systématiquement une molécule sédatrice
- E. Privilégier la voie intramusculaire en cas de mauvaise observance au traitement

31/ Sont des antipsychotiques de seconde génération :

- A. L'aripiprazole
- B. La clozapine
- C. L'halopéridol
- D. Le sulpiride
- E. La rispéridone

32/ Sont des antipsychotiques de première génération :

- A. La chlorpromazine
- B. L'amisulpride
- C. L'olanzapine
- D. La quétiapine
- E. La fluphénazine

33/ Un switch vers un autre antipsychotique est envisagé en cas d'une absence de réponse à l'antipsychotique prescrit qui est objectivée après :

- A. Une semaine de prise régulière
- B. 3 semaines de prise régulière
- C. 3 à 4 semaines de prise régulière
- D. 4 à 6 semaines de prise régulière
- E. 6 à 8 semaines de prise régulière

34/ Le bilan pré-thérapeutique d'un antipsychotique doit comprendre :

- A. Une prise de la tour de taille
- B. Un bilan lipidique
- C. Un ECG
- D. Une NFS
- E. Une protéinurie de 24 heures

35/ Le syndrome malin des neuroleptiques se manifeste par :

- A. Une hyperthermie > 39°C
- B. Une tachycardie
- C. Une rigidité musculaire
- D. Des troubles de la conscience
- E. Une sécheresse buccale

CAS CLINIQUE

Vous recevez aux urgences Mme S., âgée de 24 ans, qui a été amené par les forces de l'ordre. C'est sa mère qui les a alerté devant des troubles du comportement.

Mme S. est célibataire, sans amis ni activités de loisirs. Elle est actuellement au chômage après avoir démissionné d'un emploi à la Poste car elle se sentait menacée par ses collègues. Elle vit seule depuis trois mois.

Mme S. est suivie en psychiatrie depuis trois ans. Lorsque vous la voyez, elle vous explique avoir attendu assise dans un parc jusqu'à 4 heures du matin « *pour recevoir la commande divine, car je suis la seule à être brillante et clairvoyante pour la saisir* ». Les passants dans le parc « *avaient leur visages qui se déformaient ou avaient des têtes de diables* », dit-elle.

Mme S. portait trois pulls alors qu'on était en plein mois de juillet. Lorsqu'elle parle, vous remarquez par moment qu'elle s'arrête puis, par moments, quand elle recommence, que le son de sa voix décroît progressivement pour devenir inaudible. A deux reprises pendant l'entretien, la patiente tourne brutalement la tête derrière elle sans raison manifeste. Mme S. vous explique ne plus prendre ses traitements par injections d'antipsychotiques à action prolongée car « *ils l'empêchent d'entendre Dieu* ». Elle vous explique qu'en effet, il lui parle, et que parfois il lui déplace la main pour qu'elle prenne des objets. Elle précise qu'elle espère bien sortir de l'hôpital rapidement « *pour appliquer la commande* » et termine l'entretien en vous disant cette phrase tout en souriant : « *Je stress pour rentrer en contact, le contact c'est de la peur qui se transforme et parano pour donner la violence, et cette violence explique les tourbillons de l'enfer qui font peur.* »

1/ Quelle est votre hypothèse diagnostique principale ?

- A. Schizophrénie
- B. Épisode manique, dans le cadre d'un trouble bipolaire de type 1
- C. Bouffée délirante aiguë
- D. Psychose hallucinatoire chronique
- E. Confusion mentale

2/ Quels éléments de l'énoncé font partie du syndrome de désorganisation ?

- A. Le son de sa voix décroît progressivement pour devenir inaudible
- B. Vous vous apercevez que la patiente, en plein mois de juillet, porte trois pulls
- C. Les passants dans le parc « *avaient leur visages qui se déformaient* »
- D. La patiente tourne brutalement la tête derrière elle sans raison manifeste
- E. Elle vous explique que Dieu lui parle

3/ Quels éléments sémiologiques évocateurs du syndrome de désorganisation sont présents dans cette observation ?

- A. Catatonie
- B. Néologisme
- C. Clinophile
- D. Fading
- E. Barrage

4/ Quels thèmes délirants sont présents dans cette observation ?

- A. Mégalomaniaque
- B. Jalousie
- C. Mystique
- D. Somatique
- E. De référence

5/ Quels éléments sémiologiques sont mis en évidence dans l'observation ci-dessus ?

- A. Attitude d'écoute
- B. Maniérisme gestuel
- C. Syndrome d'automatisme mental
- D. Apragmatisme
- E. Avolition

CAS CLINIQUE

Mr. Omar, âgé de 20 ans, est amené aux urgences par les membres de protection civile suite à une tentative de suicide. Il aurait sauté d'un pont parce qu'une voix le lui soufflait. Mr. Omar est l'aîné d'une fratrie de 4. Il n'a pas achevé son cursus scolaire. Il est au chômage. Il n'a pas d'antécédents personnels organiques. Son oncle et ses deux cousins paternels sont suivis pour une schizophrénie.

Le début des troubles remonte à environ quatre ans. Le patient a commencé à se replier sur lui-même avec une tendance à l'isolement. Il ne s'intéressait plus à avoir des amis. Il passait la quasi-totalité de ses journées dans sa chambre. Il avait présenté concomitamment des difficultés scolaires avec deux redoublements consécutifs. Il a quitté le lycée il y a deux ans. Sa mère voulait qu'il fasse une formation professionnelle en mécanique. Il n'a pas pu l'achever.

Ces dernières semaines, les parents de Mr. Omar notent un changement inexplicable de son comportement. La communication devient très difficile avec lui. Il passe de plus en plus de temps à l'extérieur. Il disparaît des jours, des fois des semaines. « *Je trainais avec des amis* » dit-il. Il commence à fumer du tabac et du cannabis. Ces parents ont également noté qu'il devenait de plus en plus méfiant. Il sélectionnait les aliments selon leurs couleurs et ne mangeait que les repas emballés.

A l'entretien, Mr. Omar était très angoissé, méfiant et réticent. Il était instable sur le plan moteur. Il avait des attitudes d'écoute et de contemplation. Il répétait sans cesse « *le miroir est ensorcelé. Il déforme les visages* ». Il a refusé de continuer l'entretien. « *Vous savez tout ! Vous êtes capables de lire dans mes pensées. Je sais aussi que la nourriture est empoisonnée* ». Il refusait le traitement et les soins.

1/ Parmi ces propositions, lesquelles correspondent au tableau clinique présenté par ce patient ?

- A. Le délire est polythématique
- B. Le patient présente des hallucinations auditives
- C. Le délire est systématisé
- D. Le patient présente des hallucinations visuelles
- E. Le délire est de type paranoïaque

2/ Hormis la présence d'un délire chronique, quels sont les éléments cliniques qui vous ont permis de poser le diagnostic de schizophrénie ?

- A. Durée d'évolution des troubles supérieure à six mois
- B. Présence d'une désorganisation associée au délire
- C. Mécanisme interprétatif des idées délirantes
- D. Apparition insidieuse des symptômes
- E. Absence de diagnostic différentiel

3/ Une cure d'ECT peut être indiquée en première intention chez ce patient devant :

- A. La présence d'une forme catatonique
- B. Le risque suicidaire majeur
- C. La résistance aux antipsychotiques
- D. La présence de mouvements anormaux
- E. La présence d'injonctions hallucinatoires

4/ Pour le traitement pharmacologique, vous envisagez la prescription d'un antipsychotique atypique. Le bilan pré-thérapeutique comportera :

- A. Une NFS
- B. Un ECG
- C. Un bilan hépatique
- D. Une protéinurie de 24 heures
- E. Une glycémie à jeun

5/ Quels sont les facteurs de mauvais pronostic identifiés chez ce patient ?

- A. Sexe masculin
- B. Durée prolongée de psychose non traitée
- C. Début tardif
- D. Mauvais insight
- E. Traitement antipsychotique précocement instauré